

Draft SOP Filtering prioritas project HTO

Kartika Putri <kartikaqp12@gmail.com>
To: Kartika Putri <kartikaqp12@gmail.com>

Tue, Aug 18, 2026 at 9:49 PM

RUMAH SAKIT [NAMA RUMAH SAKIT]

HOSPITAL TRANSFORMATION OFFICE (HTO)

| PEMBERLAKUAN | NOMOR DOKUMEN | NOMOR REVISI | HALAMAN |

| [Tanggal Berlaku] | SOP/HTO/001/2026 | 02 | 1 dari 8 |

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (SOP)

FILTRASI, PANDUAN PROBING, DAN PENILAIAN PRIORITAS PROYEK TRANSFORMASI & IT

| Dibuat Oleh: | Diperiksa Oleh: | Disetujui Oleh: |

| [Nama Anda]

Asisten Manajer HTO | [Nama Manajer]

Manajer HTO | [Nama Direktur]

Direktur Utama RS |

1. TUJUAN

- 1.1. Menyediakan pedoman tata kelola yang objektif, transparan, dan terukur dalam menerima, menggali detail (*probing*), memfiltrasi, serta menetapkan prioritas usulan proyek IT dan transformasi di Rumah Sakit.
- 1.2. Menyediakan instrumen penggalian informasi untuk merespons usulan proyek yang bersifat superfisial/tidak lengkap (*vague requirement*) dari unit kerja menjadi variabel terukur.
- 1.3. Memastikan seluruh proyek selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) RS, KPI Direktur Utama, regulasi Kemenkes (RME/SATUSEHAT), Kemenkeu, BPJS Kesehatan, UU Pelindungan Data Pribadi (PDP), serta standar akreditasi JCI.
- 1.4. Mengoptimalkan alokasi sumber daya IT dan finansial rumah sakit secara dinamis setiap minggu.

2. RUANG LINGKUP

SOP ini berlaku bagi seluruh permintaan proyek pengembangan sistem, implementasi aplikasi, otomatisasi proses bisnis, infrastruktur IT, dan transformasi digital yang diajukan oleh unit/departemen/instalasi medis maupun non-medis di lingkungan Rumah Sakit kepada Hospital Transformation Office (HTO).

3. REFERENSI & DASAR TEORI PENILAIAN

No		
3.1	PMI Standard for Portfolio Management (4th Ed.)	Dasar penyusunan <i>Weighted Scoring Model</i> , tata kelola portofolio, dan evaluasi kelayakan <i>Value vs Capacity</i> .
3.2	AHP (Analytical Hierarchy Process) - Saaty	Dasar penentuan proporsi bobot indikator agar mencerminkan prioritas strategis organisasi secara matematis.
3.3	JCI Accreditation Standards (GLD & MOI)	Dasar penilaian kepatuhan <i>Governance, Leadership, Direction</i> dan keselamatan pasien (<i>IPSG</i>).
3.4	HIMSS Digital Health Indicator (DHI) & EMRAM	Dasar penilaian tingkat maturitas IT kesehatan, otomatisasi alur klinis, dan integrasi data medis.
3.5	Gartner Value of Investment (VOI) Framework	Dasar kuantifikasi manfaat non-moneter (efisiensi <i>Man-Hours</i> , reduksi risiko/eror, peningkatan PX/UX).
3.6	COBIT 2019 & UU No. 27/2022 (PDP)	Dasar penilaian kelayakan arsitektur teknis, kepatuhan hukum data pribadi pasien, dan keamanan siber.
3.7	Regulasi Pemerintah & BPJS	Permenkes Rekam Medis Elektronik (RME), Integrasi SATUSEHAT, serta aturan klaim BPJS Kesehatan.

4. DEFINISI

4.1. **Hospital Transformation Office (HTO)**: Unit kerja pengelola tata kelola portofolio proyek, inovasi, dan transformasi digital di Rumah Sakit. 4.2. **Mandatory Project (Proyek Wajib)**: Proyek bernilai kepatuhan mutlak akibat regulasi hukum, aturan BPJS, ancaman keselamatan jiwa (*Sentinel Event*), atau kelangsungan operasional kritis. 4.3. **Superficial Requirement**: Pengajuan usulan proyek dari unit kerja yang belum memiliki rincian teknis, justifikasi kuantitatif, atau dampak bisnis yang jelas. 4.4. **Probing Assessment**: Proses wawancara/klarifikasi terstruktur oleh analis HTO untuk mengubah *superficial requirement* menjadi variabel kuantitatif yang dapat dinilai. 4.5. **Value of Investment (VOI)**: Metode pengukuran manfaat proyek yang memperhitungkan konversi efisiensi waktu kerja (*FTE Equivalent*), penghematan biaya tak langsung (*cost avoidance*), dan kepuasan pengguna.

5. KEBIJAKAN UTAMA

5.1. Mekanisme Filtrasi Dua Tingkat (Two-Tier Filtering):

- Tier 1 (Mandatory Gate)**: Proyek wajib regulasi/risiko tinggi mendapatkan status *Bypass* (Priority 0).
- Tier 2 (Weighted Scoring 1–10)**: Proyek non-mandatory dinilai menggunakan 5 kriteria pembobotan terukur.

5.2. Financial & Value Gatekeeper:

- Skor Aspek Finansial & VOI bernilai ≤ 3\$ mengunci proyek pada status *Under Review/Pending*, dan membutuhkan re-justifikasi atau persetujuan khusus Direksi.

5.3. Prinsip Penanganan Usulan Superfisial:

- Tim HTO **dilarang menolak langsung** usulan proyek yang belum jelas. Tim HTO wajib melakukan *Probing Session* menggunakan lembar pertanyaan terstruktur dalam SOP ini.

5.4. Dinamisasi Mingguan (Dynamic Prioritization):

- Urutan pemeringkatan proyek diperbarui setiap minggu dalam *Weekly HTO Prioritization Meeting* berdasarkan dinamika masuknya proyek baru.

6. MATRIKS KRITERIA & PEMBOBOTAN SKOR (TIER 2)

Nilai Akhir Prioritas dihitung menggunakan formula:

$$\text{Total Skor} = (K_1 \times 0.20) + (K_2 \times 0.20) + (K_3 \times 0.25) + (K_4 \times 0.20) + (K_5 \times 0.15)$$

Kriteria Penilaian	Dasar Ilmiah & Fokus Penilaian
--------------------	--------------------------------

Kode		Bobot	
\$K_1\$	Kesesuaian Strategis & Inovasi	20%	Keselarasan dengan Renstra RS, KPI Dirut, dan <i>Competitive Advantage</i> RS.
\$K_2\$	Keselamatan Pasien & Mutu Service (PX/UX)	20%	Pengurangan kerentanan medis (JCI IPSG) dan pemangkasan hambatan alur nakes/pasien.
\$K_3\$	Kelayakan Finansial & VOI (Financial Gate)	25%	ROI kuantitatif, <i>cost saving</i> , potensi revenue, atau penghematan man-hours (FTE).
\$K_4\$	Arsitektur Teknis & Keamanan Data PDP	20%	Kompleksitas ketergantungan sistem, kepatuhan UU PDP, dan mitigasi risiko siber.
\$K_5\$	Urgensi Waktu & Quick Win (Time-to-Value)	15%	Kecepatan penyerahan hasil (<i>value delivery</i>) dan pembebasan <i>blocker</i> proyek lain.

7. RUBRIK PENILAIAN & PERTANYAAN PROBING (PENGALI DETAIL)

Gunakan pertanyaan *probing* di bawah ini saat melakukan evaluasi usulan dari pemohon (*user*) untuk menentukan skor 1–10 secara akurat:

7.1. Kriteria \$K_1\$: Kesesuaian Strategis & Inovasi (Bobot: 20%)

- **Pertanyaan Probing untuk User:**
 1. "Pilar Renstra atau KPI Direktur mana yang didukung oleh proyek ini?"
 2. "Apakah fitur ini sudah dimiliki oleh RS pesaing, atau membuat RS kita menjadi pelopor?"
- **Rubrik Skoring:**
 - **Skor 1–3:** Usulan hanya untuk kenyamanan internal 1 sub-unit; tidak ada kaitan dengan KPI Dirut atau Renstra.
 - **Skor 4–6:** Membantu pencapaian KPI tingkat departemen; menyamai standar operasional RS kompetitor.
 - **Skor 7–8:** Berdampak langsung pada 1–2 KPI Dirut; memberikan fitur layanan unggulan dibanding kompetitor lokal.
 - **Skor 9–10:** Menjadi penopang utama Pilar Strategis RS & KPI Utama Dirut; terobosan inovasi baru (*Pioneering/USP* RS).

7.2. Kriteria \$K_2\$: Keselamatan Pasien, Mutu & Pengalaman Pengguna / PX & UX (Bobot: 20%)

- **Pertanyaan Probing untuk User:**
 1. "Apakah ketiadaan sistem ini berpotensi menimbulkan kesalahan medis (*medical error*) atau komplain pasien?"
 2. "Berapa banyak langkah manual / formulir kertas yang bisa dipangkas untuk dokter, perawat, atau staf?"
- **Rubrik Skoring:**
 - **Skor 1–3:** Tidak berdampak pada alur klinis maupun pengalaman pasien; perbaikan tampilan/kosmetik administrasi.
 - **Skor 4–6:** Memperbaiki efisiensi alur kerja 1 unit internal tanpa dampak langsung ke pasien/nakes utama.
 - **Skor 7–8:** Secara langsung memotong durasi antrean pasien $>30\%$ ATAU memangkas beban input manual nakes.
 - **Skor 9–10:** Berdampak kritikal mencegah *Sentinel Event* / *IPSG JCI* DAN menghapuskan *burnout* administrasi nakes secara masif.

7.3. Kriteria \$K_3\$: Kelayakan Finansial & VOI (Bobot: 25%) - **FINANCIAL GATEKEEPER**

- **Pertanyaan Probing untuk User:**

1. "Berapa jam kerja staf per hari yang terbangun untuk proses manual ini jika dikonversi ke rupiah?"
2. "Apakah proyek ini menambah pendapatan langsung, atau mencegah potensi klaim BPJS/piutang tertahan?"

- **Rubrik Skoring:**

- **Skor 1–3 (Red Zone):** Payback Period >3 tahun; efisiensi jam kerja <50 jam/bulan; tidak ada dampak revenue/saving. (*Requires Gating Review*).
- **Skor 4–6 (Yellow Zone):** Payback Period 1.5–3 tahun; efisiensi jam kerja 50–200 jam/bulan; *cost saving* skala kecil.
- **Skor 7–8 (Green Zone):** Payback Period 6–18 bulan; efisiensi jam kerja 200–500 jam/bulan (setara 1–2 FTE); mencegah potensi kerugian finansial.
- **Skor 9–10 (Gold Zone):** Payback Period <6 bulan; ROI $>50\%$; efisiensi jam kerja >500 jam/bulan ($> \text{Rp } 100 \text{ Juta/tahun}$).

7.4. Kriteria \$K_4\$: Arsitektur Teknis, Ketergantungan & Keamanan Data PDP (Bobot: 20%)

- **Pertanyaan Probing untuk User/Tim IT:**

1. "Apakah proyek ini menjadi syarat utama agar aplikasi/sistem lain di RS bisa berjalan?"
2. "Apakah sistem ini mengolah data medis sensitif yang wajib dienkripsi sesuai UU PDP?"

- **Rubrik Skoring:**

- **Skor 1–3:** Sistem berdiri sendiri (*standalone*), menambah beban *maintenance* IT, belum ada standar keamanan data.
- **Skor 4–6:** Membutuhkan integrasi ringan dengan 1–2 sistem internal; dampak keamanan siber rendah.
- **Skor 7–8:** Menjadi prasyarat (*prerequisite*) bagi 1–2 proyek strategis lain; memenuhi standar kontrol akses RME.
- **Skor 9–10:** Proyek *Core Enabler* (fondasi utama portofolio IT RS); menutup celah kerentanan kritis siber & patuh penuh UU PDP.

7.5. Kriteria \$K_5\$: Urgensi Waktu & Quick Win / Time-to-Value (Bobot: 15%)

- **Pertanyaan Probing untuk User:**

1. "Berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai manfaat pertama (*first deliverable*) dapat dirasakan pengguna?"
2. "Apakah ada tenggat waktu khusus (*deadline*) yang jika terlewati akan membatalkan manfaat proyek?"

- **Rubrik Skoring:**

- **Skor 1–3:** Waktu implementasi >12 bulan; dampak baru terasa dalam jangka panjang.
- **Skor 4–6:** Waktu implementasi 6–12 bulan; dampak terasa bertahap.
- **Skor 7–8:** Waktu implementasi 3–6 bulan; memberikan perbaikan langsung yang terukur.
- **Skor 9–10:** *Quick Win* (<3 bulan); memberikan perbaikan instan dan menyelesaikan keluhan kritis pengguna.

8. INSTRUMEN LEMBAR KERJA EVALUASI HTO (SCORING CHECKLIST)

Analisis HTO wajib mengisi formulir berikut saat memproses usulan proyek:

=====

FORMULIR EVALUASI PRIORITAS PROYEK HTO

=====

Nama Proyek : _____

Unit Pemohon : _____ Tanggal Pengajuan: _____

Analisis HTO : _____

TAHAP 1: FILTRASI MANDATORY (TIER 1 BYPASS CHECK)

-
- [] YES [] NO 1. Apakah diwajibkan Regulasi (Kemenkes/Kemenkeu/UU PDP)?
 [] YES [] NO 2. Apakah berdampak pada Akreditasi JCI / Lisensi RS / BPJS?
 [] YES [] NO 3. Apakah mencegah Risiko Kritis (Patient Safety / Downtime)?

*Jika SALAH SATU dijawab "YES", Proyek Kategori: MANDATORY (Priority 0 - Fast Track).

*Jika SEMUA dijawab "NO", Lanjutkan ke Tahap 2.

TAHAP 2: PENILAIAN PEMBOBOTAN KRITERIA (TIER 2 WEIGHTED SCORING)

Kriteria Evaluasi	Skor (1-10)	Bobot	Skor Tertimbang
-------------------	-------------	-------	-----------------

K1. Kesesuaian Strategis & Inovasi	[_____]	x 0.20	= [_____]
K2. Keselamatan Pasien, Mutu & PX/UX	[_____]	x 0.20	= [_____]
K3. Finansial & VOI (Financial Gate)	[_____]	x 0.25	= [_____]
K4. Arsitektur Teknis & PDP	[_____]	x 0.20	= [_____]
K5. Urgensi Waktu & Quick Win	[_____]	x 0.15	= [_____]

TOTAL SKOR AKHIR PRIORITAS = [_____]

=====

STATUS KELAYAKAN FINANSIAL (GATEKEEPER CHECK):

- [] APPROVED : Skor K3 > 3 (Lolos ke Master Queue)
 [] GATED : Skor K3 <= 3 (Memerlukan Justifikasi Ulang / Diskresi Direksi)

CATATAN HASIL PROBING ANALIS HTO:

9. PROSEDUR PELAKSANAAN RE-PRIORITASI DINAMIS

9.1. Penerimaan & Probing (Senin - Rabu):

- HTO menerima usulan, melakukan wawancara *probing* jika pengajuan bersifat superfisial, dan mengompilasi bukti pendukung.

9.2. Scoring & Gating Review (Kamis):

- Tim HTO menyelenggarakan rapat internal scoring mingguan untuk mengisi Lembar Kerja Evaluasi HTO dan mengkalkulasi Total Skor Akhir.

9.3. Pembaruan Master Queue & Publikasi (Jumat):

- HTO memasukkan nilai baru ke dalam *Master Project Queue*.
- Urutan prioritas diperbarui secara otomatis. Proyek mandatory berada di puncaknya, diikuti oleh proyek non-mandatory sesuai urutan skor tertinggi.
- Laporan *Master Queue* dipublikasikan kepada Direksi dan Kepala Unit.

10. BAGAN ALIR (FLOWCHART)

[Usulan Proyek Masuk dari Unit/Departemen]



[Sesi Probing Analis HTO]
 (Konversi Usulan Superfisial -> Kuantitatif)

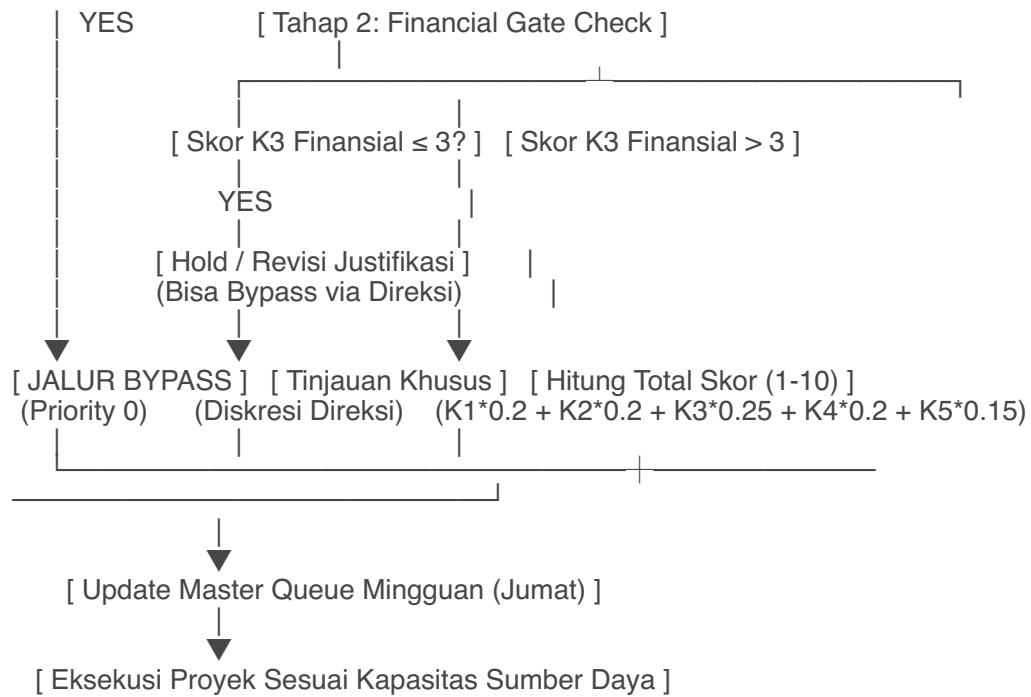


[Tahap 1: Evaluasi Mandatory]



[Memenuhi Kriteria Mandatory?]	[Tidak]
(Regulasi / Compliance / Risk)	





11. LAMPIRAN

11.1. Formulir Pengajuan Proyek HTO (*Project Initiation Form*).

11.2. Lembar Wawancara Probing & Evaluasi Skor HTO.